

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	主動脈剝離的護理 Aortic Dissection Nursing Care				
	編號	制定者	公布日期	修正日期	檢閱日期
編號	A31000-Q03-W-B13	SI 朱卉愉	98 年 05 月 31 日	111 年 11 月 08 日	
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	111 年 11 月 08 日
版本/總頁數	第 3.6 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 10 月 02 日

一、目的

讓護理人員了解主動脈剝離的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

（一）定義

動脈剝離之定義為任何主動脈段落有其結構上之問題，使其主動脈內之血流被導引從真腔經過內膜撕裂處，進入主動脈壁中產生所謂的假腔。主動脈剝離分為 A 型：包括升主動脈、主動脈弓、降主動脈處的剝離。B 型：僅局限於降主動脈的剝離。

（二）症狀

視主動脈剝離的範圍而定，一般有瞬間的劇痛，但不同於心肌梗塞的持續幾秒或幾分。痛沿著主動脈的方向或其主要的分枝輻射到背、頸、腹部或腿。主動脈雜音、不對稱的脈搏或血壓、尿量減少或無尿、腸胃不適、呼吸困難。

（三）常見檢查

1. 胸部 X-ray。
2. 電腦斷層攝影。
3. 主動脈攝影。
4. 超音波。

主題名稱	主動脈剝離的護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B13	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	2/6

5. 核磁共振。

6. 經食道心臟超音波攝影。

(四) 常見治療

1. Type A 剝離：須立即手術。

2. Type A 合併主動脈弓剝離：須立即手術。

3. Type B 剝離：除非持續疼痛或再發疼痛、無法控制血壓外、否則先以內科治療。

4. 控制血壓為原則。

(五) 護理問題

1. 低心輸出量。

2. 呼吸道清除功能不良。

3. 心肺血流不足。

4. 疼痛不適。

5. 易感染。

(六) 護理措施及衛教指導

1. 持續監測心電圖、血壓、中心靜脈壓值，以維持收縮壓 SBP 值：100-110 mmHg，中心靜脈壓值：10-12mmHg，若有早發現心肌缺血的徵象（ST 間段上揚或 T 波倒轉情形），要立即報告醫師。

2. 依醫囑每班評估意識程度，測量四肢血壓、脈搏及雙下肢膚色、脈搏強度、溫度的變化，及活動能力並作詳細記錄。

3. 協助病人做相關性之經食道超音波檢查(TEE)、主動脈血管攝影、核磁共振。

4. 詳細記錄每 8 小時輸出、入量，每小時觀察尿量並維持 1ml/Kg/hr。

5. 若病人使用強力降血壓時，如 β -block、labetalol、Nipride，依醫囑予裝置動脈導管，以便隨時觀察血壓的變化，以調整藥物。

6. 限制病人臥床休息，姿態以病人最舒適為原則，不需限制其身體活動，每 2 小時協助翻身拍背，並檢視背部及雙側會陰部有無紅斑、紅疹。

7. 需注射 Nipride 強力降壓藥時，需避光，使用微量點滴注射器來控制滴數。

主題名稱	主動脈剝離的護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B13	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	3/6

- 8.Nipride 使用超過 72 小時，若病人血壓仍未降，提醒醫師增加口服藥劑量或改用其它降壓藥物，以免產生毒性。
- 9.Nipride 使用過程中，若有肺動脈導管存留，需注意周邊血管的阻力(SVR)，維持 $770-1500 \text{ dyne}\cdot\text{sec}/\text{cm}^5\cdot\text{m}^2$ 。
- 10.若病人做經食道超音波檢查，請醫師予以解釋禁食 8 小時以上，檢查後 1 小時試喝開水，有喉反射方可進食。
- 11.避免病人用力解便而使血壓突然上升，必要時通知醫師予以軟便劑使用。
- 12.依醫囑適時給予止痛劑：Demerol，Morphine。
- 13.注意病人心理感受、緩解焦慮。
- 14.密切觀察主動脈瘤破裂的表徵：腹主動脈瘤破裂時，腹部有搏動性疼痛、有劇烈背痛及休克反應、側腹部及會陰部有紅斑、白血球計數升高、紅血球計數降低；升主動脈瘤剝離會引起劇烈背痛、兩手血壓差異大、合併急性心包填塞。

(七) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 張美玉、劉慧玲(2020)．實用重症護理學，五南。
- (二) 蔡仁貞、梁穎、洪美英、高秋惠、楊易宏、張效煌、李瓊淑(2020)．心臟疾病之護理．新編內外科護理學下冊（第八版，739-886 頁），華杏。

主題名稱	主動脈剝離的護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B13	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	4/6

七、附件

(略)

主題名稱	主動脈剝離的護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B13	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	5/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定。	98 年 05 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.08.31	2.1	修改錯別字。	100 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
101.08.31	2.2	1.醫護部改護理部。 2.第三項第六目之 1.英文縮寫改成中文說明。	101 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.08.31	3.1	說明內容部份修辭。	102 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.06.02	3.2	新增第六項參考資料。	104 年 06 月 02 日 護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.3	新增文獻出處於內文中。	105 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.04.11	3.4	第三項第七日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 04 月 11 日照 護標準組會議通過； 108 年 05 月 15 日護 理長會議通過；108 年 05 月 20 日督導會 議通過公布。
109.08.06	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	主動脈剝離的護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B13	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	6/6

修正日期	版本	修正說明	備註
110.10.19	3.5	第三項說明內容 APA 格式修訂。	110 年 10 月 07 日照護標準組會議通過；110 年 10 月 13 日護理長會議通過；110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。
111.11.08	3.6	1. NANDA 護理診斷更新為護理問題。 2. 內文參考文獻引用刪除。 3. 更新第六項參考文獻。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過；111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.10.26	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.10.15	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.10.02	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	